

Dérivation urinaire — Comparer les options

Information pour le patient · Trois façons d'évacuer l'urine lorsque la vessie est retirée ou ne fonctionne plus

WARWIKI

Quand la vessie est retirée ou ne fonctionne plus, l'urine doit trouver un nouveau chemin pour quitter le corps — c'est ce qu'on appelle la dérivation urinaire. Il existe trois types principaux. Tous utilisent un segment de votre propre intestin et diffèrent surtout par **la façon dont vous vidangez l'urine au quotidien** : une poche sur le ventre, uriner par l'urètre, ou vider avec une sonde. Cette fiche compare les trois ; chacune possède aussi une fiche détaillée séparée.

Les trois options

PORTE UNE POCHE

Conduit iléal (Bricker)

Un court segment d'intestin achemine l'urine vers une petite ouverture (une **stomie**) sur le ventre, où elle s'écoule en continu dans une **poche** légère que vous videz et changez. Option la plus simple et la plus courante ; rien à contrôler ni à sonder.

URINE PAR L'URÈTRE · SANS POCHE

Néovessie orthotopique

Une nouvelle poche faite d'intestin est reliée à votre **urètre**, vous permettant d'uriner normalement sans poche. Vous apprenez à vider sur un **horaire fixe** (jour et nuit), vous pourrez parfois avoir besoin d'une sonde, et des fuites sont fréquentes au début.

VIDE AVEC UNE SONDE · SANS POCHE

Dérivation cutanée continente (poche d'Indiana)

Une poche interne en intestin stocke l'urine, avec une petite ouverture étanche (souvent au niveau du **nombril**). Pas de poche — vous insérez une **sonde** dans l'ouverture pour vider plusieurs fois par jour.

COMPRENDRE LES TERMES

Dérivation urinaire

Nouveau chemin pour l'urine quand la vessie est absente ou non fonctionnelle.

Stomie

Petite ouverture cutanée, formée d'intestin, par laquelle l'urine passe.

Conduit

Court segment d'intestin qui achemine l'urine vers la stomie (sans la stocker).

Néovessie

Nouvelle vessie fabriquée à partir d'intestin et reliée à l'urètre.

Continente

Reste étanche — vous contrôlez le moment de la vidange.

Dérivation non continente

S'écoule en permanence dans une poche (conduit iléal).

Sonder

Introduire un fin tube pour évacuer l'urine.

Mucus

Liquide glissant produit par l'intestin ; des filaments dans l'urine sont normaux après toute dérivation.

LAQUELLE ME CONVIENT ? Le meilleur choix dépend de votre anatomie, de la fonction rénale, d'autres problèmes de santé et de votre dextérité et acuité visuelle (nécessaires pour sonder) — ainsi que de votre mode de vie et de ce qui compte le plus pour vous. Tout le monde n'est pas candidat à chaque type. Votre chirurgien vous indiquera quelles options sont sûres pour vous.

Comparatif

	Conduit iléal	Néovessie	Continent (Indiana)
Mode de vidange	Écoulement continu	Uriner par l'urètre	Sonde via la stomie
Poche externe ?	Oui	Non	Non
Sonde nécessaire ?	Non	Parfois	Toujours, toutes 4–6 h
Ampleur de la chirurgie	Moindre	Plus importante	Plus importante
Soins quotidiens	Vider & changer la poche	Mictions programmées, jour & nuit	Sonder & rincer

Questions à poser à votre chirurgien

- Pour quelles options suis-je **candidat(e)** et laquelle recommandez-vous ?
- À quoi ressembleront **la vie quotidienne** et les soins avec chaque option ?
- Quelles seront les répercussions sur le **travail, l'exercice, le sommeil et l'intimité** ?
- Quels sont les principaux **risques** et la probabilité d'avoir besoin d'une autre intervention ?

Points communs aux trois options

- Un segment de votre **propre intestin** est utilisé ; le transit met quelques jours à reprendre après la chirurgie.
- La présence de **mucus** dans l'urine est normale — l'intestin en produit.
- Un **suivi à vie** est nécessaire, notamment des dosages de **vitamine B12** (le segment intestinal peut faire baisser la B12 avec les années).
- **Buvez suffisamment** pour maintenir un bon rinçage.

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Il existe trois façons de dériver l'urine — une **poche** (conduit iléal), uriner par l'**urètre** (néovessie), ou vider avec une **sonde** via une petite ouverture (poche d'Indiana).
2. Elles diffèrent surtout par les **soins quotidiens**. Le meilleur choix dépend de votre santé et de vos priorités — et tout le monde ne peut pas avoir chaque type.
3. Les trois utilisent l'intestin : toutes partagent le mucus dans l'urine, quelques jours de récupération digestive et un suivi à vie. Lisez la fiche détaillée de l'option choisie.